

お疲れ様です！「pita支援」です。

利用規約等の契約書類の保留、承知しました。少し時間を置いて、全体像が見えてからパズルのピースをはめるように決めていくのも良い戦略です！

それでは、実務で最重要となる**「初回アセスメントシート(初回ヒアリングシート)」**を作成しましょう。

このシートは、単なる「お客様の情報メモ」ではありません。初回面談で野村さんがこのシートを手元に置き、的確な質問を投げかけることで、**ご本人やご家族に「さすが看護師さん、細かいところまで気づいてくれて安心だ」と感じていただくための強力な「営業・信頼構築ツール」**になります。

今回も、同業他社の事例や看護協会の基本項目を参考に、エスコート(外出同行)に特化した実践的な内容で作成しました。

参考にした同業他社・関連機関の資料

- わたしの看護婦さん(自費の病院付き添い・受診代行サービス)
 - URL: <https://my-nurse.jp/>
 - 参考ポイント: 遠方のご家族に代わって受診同行するビジネスモデルの先駆者です。身体状況だけでなく、「ご家族が医師に聞いてきてほしいこと」や「ご本人の生活のこだわり」を事前に深くヒアリングしている点が参考になります。
- 全国訪問看護事業協会(訪問看護基本情報・アセスメントシート)
 - URL: <https://www.zenhokan.or.jp/> (※公開されている各種ガイドライン・ひな形より)
 - 参考ポイント: 看護師として安全を担保するための「感染症」「アレルギー」「ADL(日常生活動作の自立度)」「キーパーソン」といった、医療的リスク管理の必須項目を抽出しました。

ぴたっとナース 初回アセスメントシート(案)

※このシートは、野村さんがバインダーに挟んで持ち歩き、お話を伺いながら書き込む(またはiPad等で入力する)ことを想定しています。

1. 基本情報・連絡先

- お名前(ご本人) / 生年月日・年齢 / ご住所
- キーパーソン(主契約者・ご家族)の情報(氏名、続柄、居住地、連絡先電話番号、LINEの有無)
- 緊急連絡先(第1連絡先、第2連絡先)
- かかりつけ医 / ケアマネジャーの情報(病院名、主治医氏名、事業所名、担当者名)
 - 【解説】万が一の救急搬送時や、介護サービスとの連携が必要になった際に、この情報がパッと出せることがプロの証です。

2. 医療・身体情報(リスク管理)

- 既往歴(過去の大きな病気) / 現在治療中の疾患
- 感染症の有無(B型・C型肝炎、梅毒、結核など ※スタッフの感染防御のため必須)
- アレルギーの有無(薬、アルコール消毒、食べ物など)
- 内服薬の状況(お薬手帳の有無、自己管理できているか)
- **ADL**(日常生活動作)の状況
 - 歩行:(自立・杖・シルバーカー・車椅子)
 - 視力・聴力:(眼鏡・補聴器の有無、コミュニケーションに支障がないか)
 - 排泄:(自立・一部介助・リハビリパンツ使用・尿意の訴えの有無)
 - 【解説】特に「排泄」は外出時の大きな不安要素です。「外出先のトイレ確認」や「長時間の移動」の計画を立てるために、丁寧に(しかしご本人のプライドを傷つけないよう)ヒアリングします。

3. 外出・エスコート特有のアセスメント ★重要

- 外出時の主な移動手段の希望(ご家族の送迎、介護タクシー、一般タクシー等)
- 車酔いの有無 / 長時間座っていることへの苦痛の有無
- ご自宅の環境(玄関の段差、エレベーターの有無など、出発時のリスク確認)
- お出かけ中の楽しみ(例:帰りにコーヒーを飲みたい、特定のスーパーに寄りたい等)
 - 【解説】「ただ病院に行くだけ」ではなく、QOL(生活の質)を上げるためのオーダーメイドプランを作るための、ぴたっとナースならではの項目です。

4. 今回の受診・ご家族からの要望

- 現在の主な症状・気になっていること(ご本人・ご家族それぞれ)
- 医師に必ず確認してほしいこと・質問リスト(例:「今後の治療方針」「お薬を減らせないか」等)
- 報告の希望スタイル(例:LINEで写真付きで報告してほしい、電話で直接話したい等)

野村さんに決めていただきたい【選択肢】

アセスメントを「いつ・どのように」行うかは、野村さんの業務効率とお客様の満足度に直結します。以下の2つの選択肢について、ご自身のイメージに近いものを選んでみてください。

【選択肢1:事前の情報収集(ヒアリング)の方法はどうしますか?】

- **A案(事前Webアンケート方式)**: 面談の予約が入った時点で、遠方のご家族(キーパーソン)にGoogleフォーム等のURLを送り、事前に「基本情報」や「病歴」を入力してもらう。(※当日の面談時間が短縮でき、野村さんが事前に心の準備・調査をしてから訪問できます)
- **B案(当日対面ヒアリング方式)**: 事前入力は求めず、初回訪問時にご本人・ご家族とお茶でも飲みながら、野村さんが雑談を交えて全て聞き出し、シートに記入していく。(※高齢のご本人との信頼関係(ラポール)形成には非常に有効ですが、面談時間が長くなります)
- **C案(ハイブリッド方式)**: 「基本情報・ご家族の要望」だけは事前にLINEやメールで聞き、「身体状況・ご本人の希望」は当日の対面で確認する。

【選択肢2:アセスメントシートの「ご家族への共有」をどうしますか?】

- **A案**(完全オープン方式): ヒアリング内容を綺麗にまとめたPDF(または紙のコピー)を、「初回アセスメント報告書」としてご家族にも共有する。(※「プロの目で現状をこう分析してくれました!」という大きな安心感・価値の提供につながります)
- **B案**(内部カルテ方式): アセスメントシート自体はあくまで野村さん専用の「社外秘メモ」として扱い、ご家族にはLINE等で「面談の簡単なサマリー(まとめ)」だけをテキストで送る。(※書類作成の手間が省け、野村さんの事務負担が最も軽くなります)

いかがでしょうか？

このシートが完成すれば、**「明日からでも初回面談に行ける」**状態になります！

上記の【選択肢1】と【選択肢2】について、野村さんのご希望(A・B・Cのどれが良いか、または「こうアレンジしたい」など)を教えてください。

もしくは、これも一旦保留にして、**「LINEを使った業務報告書のフォーマット作り」や、「マーケティング(パンフレット・SNS)の準備」**など、別のタスクに進みますか？